

【科研进展】

DOI: 10.70976/j.issn.1003-8914.2026.02.026

CSTR: 32470.14.j.issn.1003-8914.2026.02.026

中医体质理论指导血脂异常健康管理体系的构建与应用研究*

余晴^{1,2} 边汝涛¹ 徐学功^{1△}

1. 郑州市中医院心病科, 河南 郑州 450000; 2. 河南中医药大学硕士研究生 2024 级, 河南 郑州 450046

摘要: 血脂异常已成为影响中国居民健康的常见慢性疾病。现有的健康管理手段虽可在一定程度上实现早筛、早治, 延缓疾病进展, 但仍存在个体化不足、干预手段单一等局限性。中医体质理论以“未病先防”为核心理念, 强调因人制宜, 通过辨体施治调整患者体质, 发挥中医药在改善临床症状, 延缓疾病进展, 提高患者生活质量方面的独特优势。此文基于中医体质理论, 构建血脂异常健康管理体系, 旨在为血脂异常的个体化管理与临床干预提供中医思路与实践路径参考。

关键词: 中医体质学说; 血脂异常; 健康管理; 未病先防

中图分类号: R589.2

文献标志码: A

文章编号: 1003-8914(2026)-02-0115-05

Study on the Construction and Application of Health Management System for Dyslipidemia
Guided by Traditional Chinese Medicine Constitution Theory

YU Qing^{1,2} BIAN Rutao¹ XU Xuegong^{1△}

1. Department of Cardiology, Zhengzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine, Henan Province, Zhengzhou 450000, China;

2. Grade 2024 Graduate, Henan University of Chinese Medicine, Henan Province, Zhengzhou 450046, China

Abstract: Dyslipidemia has become a common chronic disease affecting the health of Chinese residents. Although existing health management measures can achieve early screening and early treatment to a certain extent and delay disease progression, they still have limitations such as insufficient individualization and single intervention methods. Traditional Chinese medicine (TCM) constitution theory takes “preventing disease before its onset” as the core concept and emphasizes individualized treatment. By regulating patients’ constitutions based on constitution differentiation, TCM exerts in improving clinical symptoms, delaying disease progression and enhancing patients’ quality of life. Based on TCM constitution theory, this paper constructed a health management system for dyslipidemia, aiming to provide TCM ideas and practical references for the individualized management and clinical intervention of dyslipidemia.

Key words: traditional Chinese medicine constitution theory; dyslipidemia; health management; preventing disease before its onset

动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)已成为中国居民死亡的主要原因^[1], 而血脂异常是其关键的影响因素之一。研究显示, 中国 18 岁及以上居民血脂异常患病率已达 38.1%^[2], 防控形势严峻, 亟须建立系统有效的干预策略。当前的健康管理多基于西医学与管理学方法, 围绕个体或群体的健康风险开展系统性监测、评估、干预与随访, 其核心在于倡导健康生活方式, 从而实现慢性病的有效防控^[3]。相关研究表明, 通过系统管理血脂异常相关因素并改善生活方式, 可显著降低心血管疾病发生风险^[4,5]。然而, 传

统的管理方式在应对血脂异常的个体差异与复杂性方面仍存在不足, 亟需在既有框架基础上实现功能拓展与内涵深化。

《中医药发展“十三五”规划》^[6]指出, 要将中医药优势与健康管理相结合, 探索融健康文化、健康管理、健康保险为一体的中医健康保障模式。中医体质理论以“未病先防”为核心理念, 依据患者体质特征实施针对性调养, 通过调节体质偏颇进而恢复机体“阴平阳秘”的平衡状态, 实现防病于先、防患于未然的“治未病”目标, 体现出高度契合的个体化干预思想。本文拟通过构建融合中医药优势和现代管理特色的血脂异常健康管理体系, 为临床诊疗与慢病防控提供理论依据与实践参考。

血脂异常在中医典籍中并无直接论述, 多归为

* 基金项目: 河南省医学科技攻关项目(No.232102311192); 郑州市科技惠民计划项目(No.2023KJHM0014)

△通信作者: E-mail: xuxg1115@126.com

“肥胖”“消瘿”“痰浊”“眩晕”等范畴。脾失健运,脏腑功能失调是其主要病机,痰浊、瘀血是主要的病理产物^[7]。《素问·通评虚实论》载:“甘肥贵人,则膏粱之疾也”,指出饮食肥甘厚腻是此病主要原因。嗜食膏粱厚味,脾胃运化失常,水谷精微无以遍布全身,过则化生痰浊,阻碍气机运行,气机不畅则血运失常,停而为瘀,亦可阻碍气机,进一步加重病情,日久痰浊、瘀血相互搏结而为病^[8]。

1 血脂异常健康管理的现状与挑战

血脂异常的健康管理能够及早发现和干预血脂异常人群,有效预防 ASCVD 的发生发展^[1,9]。目前,血脂异常的健康管理主要包含以下环节^[1,10-12]: ①血脂异常筛查与风险评估: 每年至少完成 1 次血脂检测,检测内容包含总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C); ②血脂异常分层管理: 根据患者血脂水平和基础疾病实行分层管理; ③确定治疗方案: 根据患者自身情况制定个性化的生活方式干预和相应的药物治疗; ④健康宣教: 向患者传达血脂异常相关知识,结合多媒体平台传达健康信息; ⑤随访评估: 定期进行电话随访,或结合智能化设备和信息平台实现长效追踪。但健康管理多存在缺乏足够资金投入、患者主动性和参与度较低、健康管理人员积极性不高、未能发挥中医药特色优势等问题^[13-15],尚需进一步完善和发展。

2 中医体质理论指导下的血脂异常健康管理体系构建

中医体质理论是通过总结人体特征而归纳出的体质分类理论,反映了不同个体在生理、心理、病理等方面的差异,均在先天禀赋和后天获得的基础上形成的固有特征,因而具有不同的体质类型^[16,17]。国医大师王琦通过总结中医古籍文献,归纳体质特征,提出以气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质和瘀血质等 9 种体质为代表的中医体质理论^[18],为中医预防、临床、养生等健康管理工作奠定了基础。

根据中医体质辨识结果,可以评估疾病的发展趋势,预测潜在的风险,针对性地予以中医药治疗和调护,能够通过调整患者偏颇体质,有效改善患者症状,提高生活质量。特别是对高血压病、糖尿病以及其他慢性人群和易发人群颇有优势,如利用中医体质辨识对青少年代谢综合征患者进行健康管理能有效改善偏颇体质状态、改善代谢指标^[19]; 基于体

质理论指导下的辨证取穴相比常规取穴也能够明显改善慢性疲劳综合征患者的临床症状^[20]; 结合中医体质辨识制定具有中医特色的健康管理模式能够有效防治高血脂症^[21]。

因此,基于中医体质理论构建健康管理体系,能够实现早期识别高危易发人群,降低慢性病的发病率,延缓疾病进展,提高患者生活质量,是未来慢性病健康管理的新方向。

本研究基于前期研究基础,结合相关文献^[22,23]和专家论证,构建了基于中医体质理论的血脂异常健康管理体系。见图 1。

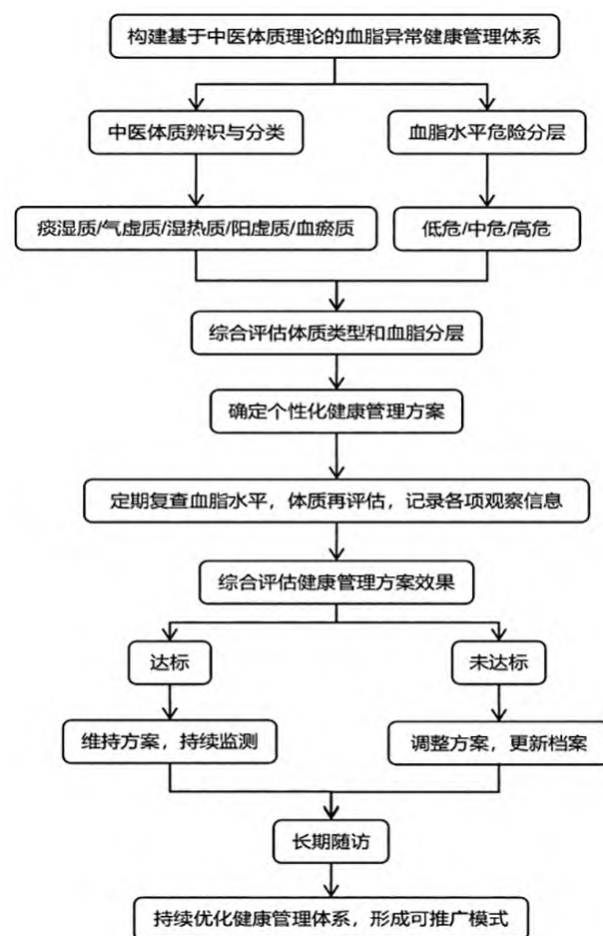


图 1 基于中医体质理论的血脂异常健康管理体系

2.1 血脂异常健康管理体系设计原则

2.1.1 体质为本 精准防控

以中医“辨质施护”为核心,先行体质辨识,再依据不同体质类型结合现代血脂分层(ASCVD 风险)制定差异化干预方案,开发双轨风险评估手册,建立个人体质动态档案。

2.1.2 全程闭环管理

从“筛查→评估→干预→监测→调整→随访”形成动态闭环,覆盖“未病先防-既病防变-瘥后防复”的三级防控,确保每一环节信息互通、效果可实

时追踪。

2.1.3 中西医结合 优势互补

将现代血脂检测与中医体质辨识数据并行收集；在高危患者中引入西医药物治疗，在中低危群体中优先发挥中医调护特色。

2.2 血脂异常中医体质辨识与分类

采用《中医体质分类与判定》^[24]进行体质标准化归属。9种体质包括：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。相关研究显示，血脂异常以痰湿质、气虚质、湿热质、阳虚质、血瘀质等体质分类较为常见^[25-30]，基于上述体质构建健康管理体系。

2.3 血脂分层与风险评估

参照《中国血脂管理指南(基层版 2024 年)》^[1]中国成年人 ASCVD 总体风险评估流程对纳入患者血脂水平进行 ASCVD 风险评估。低危风险： $3.1 \leq TC < 4.1$ 或 $1.8 \leq LDL-C < 2.6$ ；中危风险： $4.1 \leq TC < 5.2$ 或 $2.6 \leq LDL-C < 3.4$ ；高危风险： $5.2 \leq TC < 7.2$ 或 $3.4 \leq LDL-C < 4.9$ 。

2.4 制定血脂异常偏颇体质个体化健康管理方案

针对血脂异常患者的偏颇体质及血脂异常风险等级，从中药与代茶饮、饮食调摄、运动指导、情志调护、辅助理疗等方面确定个体化健康管理方案，ASCVD 的高危风险患者配合标准降脂药物治疗，复合体质以评分最高体质为准，个体化健康管理方案见图 2。

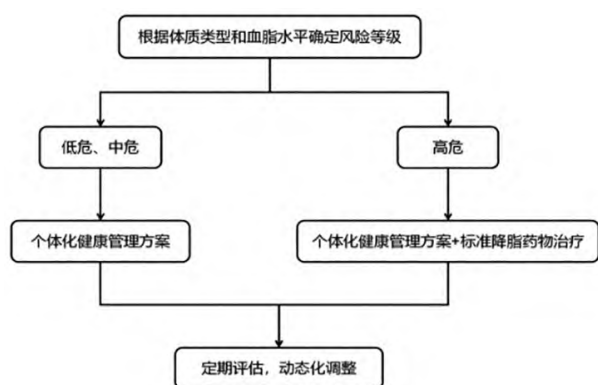


图 2 个体化健康管理方案

2.4.1 痰湿质

中药予二陈汤合平胃散加减以化痰利湿、健脾和中；代茶饮推荐陈皮茯苓茶、薏苡仁荷叶茶，有助于清利湿浊、健运脾胃。饮食应清淡少油腻，避免甜食和冷饮，常食薏苡仁、冬瓜、赤小豆、海带等有利湿化痰之品。运动宜中高强度有氧运动，如快走、游泳、跳绳等，每次 30~60 min，每周 3~5 次。情绪调摄建议适度社交，培养兴趣爱好，避免情绪郁结。辅助

理疗以通腑化痰、祛湿利气为主，推荐进行拔罐、刮痧、足浴：拔罐宜选取背部膀胱经、胃经、足阳明经穴位，如大椎、肺俞、脾俞、胃俞，促进气血运行、化痰祛湿；刮痧以背部督脉、膀胱经为宜，使用生姜油或刮痧油为介质，每周 1~2 次；足浴可选用生姜 15 g、花椒 10 g、艾叶 20 g 煎水泡脚，有助于温通阳气，改善四肢沉重、湿困倦怠等症状。

2.4.2 气虚质

中药予四君子汤加减以补气健脾；代茶饮推荐黄芪红枣茶、太子参茯苓茶，有助于益气养中，缓解疲劳。饮食以健脾益气为主，适当摄入富含优质蛋白质的食物，如山药、大枣、鸡肉、黄豆等。运动建议低强度、节奏缓慢运动，如八段锦、太极拳、慢走等，每次 30 min，每周 3~4 次。情绪调摄建议正面自我暗示增强信心，减少压力源，注重心理疏导。辅助理疗以温补元气、扶正固本为主，推荐艾灸、推拿按摩：艾灸取关元、气海、中脘、足三里等主要穴位进行温和灸，每次 15~20 min，每周 2~3 次；推拿以缓慢、均匀手法按摩脾胃经及任脉部位，可缓解疲乏、提升机体运化功能。

2.4.3 湿热质

中药予三仁汤合龙胆泻肝汤加减，以清热利湿、疏肝泻火；代茶饮推荐苦丁菊花茶、金银花淡竹叶茶，有助于清热利湿解毒。饮食宜忌辛辣油腻，少饮酒，多食绿豆、黄瓜、苦瓜、荷叶等清热利湿食物。运动建议以中等强度运动为主，如慢跑、骑车、健身操，注意排汗、避免过度疲劳。情绪调摄建议规律作息，静心养性，避免过度刺激。辅助理疗以清泄湿热、疏通腠理为主，推荐拔罐、穴位敷贴：拔罐宜选双侧曲池、足三里、阴陵泉、肝俞等穴位，重点疏导肝胆湿热；穴位敷贴可选黄连、苦参、黄柏研粉制膏敷贴相关穴位，有助于减少皮肤油腻、口苦、口干等症状。

2.4.4 阳虚质

中药予附子理中汤合肾气丸加减，以温补脾肾、扶阳固本；代茶饮推荐生姜红枣茶、桂附肉苁蓉茶，有助于温阳益气。饮食宜温补为主，宜多食羊肉、生姜、核桃、桂圆等温热性质食物，忌生冷寒凉食物。运动建议以温和运动为主，如散步、太极、轻缓瑜伽，避免早晚温差大的时候进行运动。情绪调摄建议多晒太阳，加强人际交流，增强信心与活力，避免孤僻独处。辅助理疗以温阳益火、散寒通络为主，推荐温针灸、艾灸、热敷：艾灸穴位以命门、肾俞、关元、足三里为主，每次 20 min，每周 2~3 次，灸感以温和微热为宜；热敷可使用生姜片、红花，布包热敷于腹部

或腰部。日常使用热水袋以辅助温阳散寒。

2.4.5 血瘀质

中药予血府逐瘀汤加减,以行气活血、化瘀通络;代茶饮推荐丹参红花茶、桃仁玫瑰茶,有助于改善血瘀体质。饮食宜以通络活血为主,常用黑木耳、紫米、洋葱、山楂等活血化瘀之品。运动应以改善血液循环为主,可选择有氧拉伸操、舞蹈、太极,配合深呼吸训练。情绪调摄应多行情绪调节与心理疏导,可通过谈心、静坐冥想、书写或艺术表达等方式畅通气血。辅助理疗以活血通络、化瘀止痛为主,推荐穴位按摩、刮痧、热敷:按摩穴位宜选血海、膈俞、三阴交、肝俞等,每次 10~15 min,适度按压,以出现酸胀感为宜;刮痧部位可沿膀胱经和背部督脉施刮,可使用红花油、乳香没药油作为介质;热敷可配合艾绒包热敷小腹或肢体末端,有助于温经通络、促进血液循环。

2.5 动态监测与效果评价

动态监测与效果评价是中医体质理论指导下血脂异常健康管理体系持续优化和闭环运行的重要保障环节,旨在通过周期性评估患者体质状态、血脂水平及症状改善情况,及时调整干预方案,实现个体化、精准化健康管理。

2.5.1 定期复查

至少每 3 个月进行一次常规随访检查,监测 TC、TG、LDL-C、HDL-C 等核心血脂参数,并结合体质量、腰围、身体质量指数、血压等代谢指标,动态判断干预效果。通过问卷、自我记录或随访,评估患者在健康管理方案方面的执行情况,为后续干预调整提供依据。

2.5.2 体质量表再评估

每 3~6 个月对个体体质状态进行再评估,内容包括:体质类型是否转归(如由偏颇体质向平和体质转化)、偏颇程度是否减轻(评分值变化);情志状态、饮食习惯、生活方式等是否发生积极改善。

2.5.3 干预效果动态调整

建立患者个体干预档案,详细记录每次监测结果与干预调整内容,结合复查结果和体质再评估情况,及时调整干预策略,更新健康档案,实现动态优化。具体包括:①中药和代茶饮调整:若体质状态改善明显,可适当减轻剂量或更换调理方药;若体质偏颇仍重,则需加味加减以强化治疗。②饮食与运动方案调整:根据体质评分变化、生活规律及体质量波动等因素,动态调整食疗建议和运动强度及频次。③情志与生活方式干预调整:结合患者反馈及心理状态变化,适当加强心理支持和情志调护,必要时转

介心理干预或团体辅导。④中医特色疗法优化:根据症状改善程度酌情延长、缩短或替换治疗方案。

2.6 信息管理

构建血脂异常健康管理体系需要依托系统化、标准化的信息管理手段,建立覆盖“筛查-评估-干预-随访-反馈”的全过程数据链,实现个体化服务闭环与管理精准化目标。首先,应加强健康管理信息平台建设,集成中医体质辨识与录入、健康干预方案推送、动态监测与趋势可视化、智能随访与健康宣教等核心功能。其次,应建立以患者为核心、具备动态更新能力的电子健康档案,涵盖患者基本信息、现代医学数据、体质辨识结果、干预记录、随访与复评数据等内容,所有数据采用标准格式录入,便于结构化分析、信息共享和科研整合。最后,需要完善信息安全与隐私保护机制,确保信息平台符合国家相关规范,严格保障患者隐私和数据安全。

2.7 质量控制与持续优化

为保障血脂异常健康管理体系的运行规范和干预效果,需建立涵盖全过程、多环节、可追踪的质量控制机制。首先,应制定覆盖体质辨识、风险评估、干预实施、随访评估的信息录入与档案管理等各环节的 SOP,规范各项工作的执行。其次,组建由中医师、营养师、健康管理师、心理咨询师与信息技术人员组成的多学科团队,明确职责分工,定期开展沟通协作。此外,应建立多维度评估体系,涵盖血脂水平、体质变化、自觉症状和生活质量等,依据不同时间节点反馈结果,动态调整干预方案,逐步建立干预效果数据库。最后,持续优化整体流程,构建“评估-反馈-调整-再评估”的闭环机制,持续完善干预措施、随访节奏和服务流程,探索“试点-推广”的可持续发展模式。

3 总结与展望

在血脂异常人群日益增多、慢性病防控形势日益严峻的背景下,单一的药物治疗或生活方式干预已难以满足多元化、个体化的健康管理需求。中医体质理论作为中医“治未病”思想的重要体现,为血脂异常的早期识别、分类管理和综合干预提供了新的理论依据与实践路径。本研究以中医体质辨识为基础,构建了血脂异常的中医健康管理体系框架,为慢性病防治探索了新的模式与路径。

本研究的创新之处在于:①将体质辨识与血脂风险评估深度融合,实现体质-代谢状态的双维度评估;②提出“五类常见偏颇体质”下的分型干预策略,

形成“辨体-辨证-干预-评估”一体化模式；③初步建立具有中医特色、可推广的血脂异常健康管理体系，拓展了“治未病”理念在慢病管理中的应用场景。本研究尚存在以下不足之处：体系构建以理论与初步经验为基础，尚需在更大样本、多中心、多人群中开展验证性研究；体质辨识方法仍以主观判断为主，量化工具与标准化流程有待进一步完善与推广；虽已构建相对完整管理路径，但个体在饮食、运动、情志等方面的依从性差异较大，可能影响干预效果的持续性与稳定性。

综上所述，构建基于中医体质理论的血脂异常健康管理体系，不仅拓宽了慢性病防控的新思路，也为中医“治未病”理念的现代转化与实际应用提供了参考。未来仍需在理论深化、实践验证与推广应用层面不断探索，以期为全民健康管理体系的完善贡献中医智慧与力量。

参考文献

- [1] 中国血脂管理指南修订联合专家委员会. 中国血脂管理指南(基层版 2024 年)[J]. 中华心血管病杂志, 2024, 52(4): 330-337.
- [2] 国家心血管病中心, 中国心血管健康与疾病报告编写组, 胡盛寿. 中国心血管健康与疾病报告 2023 概要[J]. 中国循环杂志, 2024, 39(7): 625-660.
- [3] 夏丽珍, 周悦, 陈祺焘, 等. 中医在健康管理中的哲学思考与实践[J]. 光明中医, 2025, 40(8): 1618-1622.
- [4] BERISHA H, HATTAB R, COMI L, et al. Nutrition and lifestyle interventions in managing dyslipidemia and cardiometabolic risk[J]. Nutrients, 2025, 17(5): 776.
- [5] HUANG QR, HU ZY, ZHENG QW, et al. A proactive intervention study in metabolic syndrome high-risk populations using phenome-based actionable P4 medicine strategy[J]. Phenomics, 2024, 4(2): 91-108.
- [6] 魏敏. 中医药发展“十三五”规划[J]. 中医药管理杂志, 2016, 24(17): 175.
- [7] 廖翠平, 高雅, 刘云璐, 等. 中医药及民族医药防治高脂血症临床研究进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2025, 27(3): 658-667.
- [8] 王佳, 李晓东, 任如画, 等. 血脂异常的中医研究进展[J]. 河北中医, 2025, 47(5): 877-880.
- [9] 张雪勤, 姜威锋, 贺娟. 血脂异常合并高血压患者健康管理的效果及成本效果调查[J]. 辽宁医学杂志, 2024, 38(4): 103-106.
- [10] 周志衡, 王皓翔, 吴晓亮, 等. 基层高血压和血脂异常共存医防融合规范化管理中国专家共识[J]. 中国合理用药探索, 2025, 22(1): 1-16.
- [11] 张俊, 罗雯, 王绿娅, 等. 综合医院血脂管理门诊模式建设探索与实践[J]. 中国全科医学, 2024, 27(36): 4527-4533.
- [12] 俞蔚, 丁芳, 张洁, 等. 高血压、高血糖、高血脂基层健康管理规范[J]. 心脑血管病防治, 2024, 24(7): 1-14.
- [13] 谭震, 朱艺, 肖苹, 等. 我国健康管理体系的发展现状及未来展望[J]. 中国社会医学杂志, 2022, 39(3): 247-251.
- [14] 孔馨雪, 赵娥, 孙高峰, 等. 高血压健康管理模式研究进展[J]. 中国慢性病预防与控制, 2023, 31(12): 931-935.
- [15] YU Y, WANG SF, YOU LJ. Understanding the integrated health management system policy in China from multiple perspectives: Systematic review and content analysis[J]. J Med Internet Res, 2024, 26: e47197.
- [16] 温金莉. 基于中医体质辨识的健康管理在社区老年慢性病患者中的应用效果[J]. 中国社区医师, 2025, 41(13): 139-141.
- [17] 蔡煜阳, 李竹青, 杨帆, 等. 中医体质辨识客观化研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2024, 39(12): 6611-6615.
- [18] 陈顺琪, 孙鹏程, 李文乐, 等. 中医主体思维下八纲理论与中医体质分类内涵探讨[J]. 中华中医药杂志, 2024, 39(9): 4694-4698.
- [19] 吕婧, 李明, 张硕, 等. 基于中医体质辨识实施健康管理对青少年代谢综合征的影响[J]. 湖北民族大学学报(医学版), 2024, 41(4): 35-38.
- [20] 冉俊宁, 罗同由, 许华峰, 等. 基于中医体质学的膈穴配伍治疗慢性疲劳综合征的临床观察[J]. 中医临床杂志, 2024, 36(8): 1599-1603.
- [21] 关媛媛, 戴鹏举, 何渝煦. 运用中医健康管理模式防治高脂血症的实践与分析[J]. 中医临床研究, 2020, 12(6): 47-51.
- [22] 林俐, 汤丽莉, 柯文琼. 以中医体质辨识为核心的健康管理体系构建思路[J]. 中医药管理杂志, 2023, 31(15): 105-107.
- [23] 沈晴晴, 张丽丽. 从中医体质学角度建立健康状态管理新模式的应用[J]. 中医药管理杂志, 2025, 33(2): 196-198.
- [24] 中华中医药学会. 中医体质分类与判定(ZYYXH/T157-2009)[J]. 世界中西医结合杂志, 2009, 4(4): 303-304.
- [25] 周毅, 朱雪琼, 林希, 等. 温州地区高脂血症患者中医体质分布规律研究[J]. 新中医, 2017, 49(3): 24-26.
- [26] 陈亚兰, 徐晓薇, 魏頔. 北京地区人群的中医体质分布及其与高脂血症的相关性[J]. 中国老年学杂志, 2019, 39(23): 5679-5682.
- [27] 张丹婷. 2378 例广州市海珠区五社区高脂血症人群中医体质分布研究[J]. 中国医药科学, 2019, 9(10): 176-179.
- [28] 童双, 吴克瑾, 沈红艺. 血脂异常与中医体质相关性研究进展[J]. 2020(7): 2454-2459.
- [29] 张冰婵, 陆琴. 高脂血症血脂水平和中医体质辨识分型的相关性研究[J]. 云南中医中药杂志, 2020, 41(6): 21-22.
- [30] 王雪可, 李天星, 丁虹, 等. 1161 例高脂血症患者中医证候及体质类型的临床特征与流行病学分析[J]. 时珍国医国药, 2025, 36(1): 88-94.

(本文编辑: 李佳丽 收稿日期: 2025-06-30)